حالة كل أسبوع™ · المكافأة 1

100 سؤال حالة مع الشرح

معطيات سريرية قصيرة، سؤال واحد، أربعة خيارات. 100 حالة في 10 مجموعات؛ وفي نهاية كل مجموعة مفتاح الإجابات وشرح قصير يوضح لماذا الإجابة صحيحة.

دليل طبيب التقويم

المحتويات

طريقة الحل

المجموعة 1 · التشخيص الأساسي والتصنيف · الأسئلة 1–10

المجموعة 2 · القياسات السيفالومترية · الأسئلة 11–20

المجموعة 3 · التخطيط والتوقيت · الأسئلة 21–30

المجموعة 4 · إدارة المسافة · الأسئلة 31–40

المجموعة 5 · الارتكاز والغرسات المصغّرة · الأسئلة 41–50

المجموعة 6 · الصنف الثاني · الأسئلة 51–60

المجموعة 7 · الصنف الثالث · الأسئلة 61–70

المجموعة 8 · المشكلات العمودية والعرضية · الأسئلة 71–80

المجموعة 9 · الميكانيكا المساعدة · الأسئلة 81–90

المجموعة 10 · الإنهاء والتثبيت والرضوض والتحام السن بالعظم · الأسئلة 91–100

الخطوة التالية

البداية

طريقة الحل

المجموعة الواحدة نحو 15 دقيقة. مجموعة واحدة في الأسبوع، بالتوازي مع البرنامج الممتد 52 أسبوعًا.

1. **حُلّ المجموعة مع حساب الوقت.** اكتب إجاباتك بجانب كل سؤال؛ ولا تنظر إلى مفتاح الإجابات.
2. **قارن بالمفتاح.** اقرأ شرح الأسئلة التي أخطأت فيها أو أصبت فيها دون يقين.
3. **ارجع إلى المصدر.** في بداية كل مجموعة تجد أرقام الوحدات والخرائط البصرية المرتبطة بها في دليل طبيب التقويم.
4. **سجّل نتيجتك.** اكتب عدد الإجابات الصحيحة والتاريخ في السطر الموجود في نهاية المجموعة؛ وأعد حل المجموعة نفسها بعد شهر.

المجموعة	الموضوع	الأسبوع المقترح
1–2	التشخيص الأساسي، القياسات السيفالومترية	خلال الأسابيع 1–11 أو بعدها
3	التخطيط والتوقيت	الأسابيع 12–16
4–5	إدارة المسافة، الارتكاز والغرسات المصغّرة	الأسابيع 17–23
6–7	الصنف الثاني، الصنف الثالث	الأسابيع 24–31
8	المشكلات العمودية والعرضية	الأسابيع 32–38
9	الميكانيكا المساعدة	الأسابيع 39–43
10	الإنهاء والتثبيت والرضوض والتحام السن بالعظم	الأسابيع 44–52

الحالات لأغراض تعليمية

المعطيات افتراضية ومبسّطة لقياس مفهوم واحد. أما مع المريض الحقيقي فيُتخذ القرار بعد فحص كامل وسجلات كاملة.

المجموعة 1 · الأسئلة 1–10

التشخيص الأساسي والتصنيف

للقراءة: الوحدة 01 والوحدة 02 · الخريطة البصرية 1، 2، 9، 10، 17، 37، 38

السؤال 1

حالة

العمر 13 سنة. علاقة الأرحاء صنف ثانٍ بوحدة كاملة في الجانبين. البروز الأفقي 8 mm، والقواطع العلوية مائلة دهليزيًا.

ما تصنيف Angle؟

أ) الصنف الثاني النوع 1

ب) الصنف الأول

ج) الصنف الثاني النوع 2

د) الصنف الثالث

السؤال 2

حالة

العمر 15 سنة. علاقة الأرحاء صنف ثانٍ. القواطع المركزية العلوية مائلة حنكيًا، والجانبية مائلة دهليزيًا، والتغطية العمودية عميقة.

ما التصنيف الأرجح؟

أ) الصنف الثاني النوع 1

ب) الصنف الأول مع عضة عميقة

ج) الصنف الثالث الكاذب

د) الصنف الثاني النوع 2

السؤال 3

حالة

العمر 10 سنوات. الرحى اليمنى صنف أول، واليسرى صنف ثانٍ بنصف وحدة. الخط المتوسط السفلي منحرف 2 mm إلى اليسار.

ما أول ما يجب فعله؟

أ) البدء فورًا بمطاط الصنف الثاني في الجانب الأيسر

ب) التخطيط لقلع الضاحك العلوي الأيسر

ج) فحص الإطباق في العلاقة المركزية والتمييز بين الانزلاق الوظيفي واللاتناظر الحقيقي

د) الانتظار سنة دون أي إجراء

السؤال 4

حالة

العمر 9 سنوات. عضة معكوسة خلفية في الجانب الأيمن. في العلاقة المركزية تتطابق الخطوط المتوسطة، وفي الإطباق المركزي ينحرف الخط المتوسط السفلي إلى اليمين.

ما التشخيص الأرجح؟

أ) لاتناظر فكي سفلي حقيقي

ب) انزلاق وظيفي بسبب ضيق الفك العلوي

ج) عضة معكوسة سنية في سن واحد

د) التحام المفصل الفكي الصدغي

السؤال 5

حالة

العمر 25 سنة. ظهور القواطع العلوية في وضع الراحة زائد. طول الشفة العلوية وأطوال التيجان طبيعية. اللثة بارزة عند الابتسام.

ما السبب الأكثر احتمالًا؟

أ) زيادة عمودية في الفك العلوي أو بزوغ مفرط سني سنخي علوي

ب) قِصَر الشفة العلوية

ج) البزوغ المنفعل

د) تراجع الفك السفلي

السؤال 6

حالة

العمر 11 سنة. لا يُجسّ الناب العلوي الأيمن دهليزيًا، بينما يُجسّ في الجانب الأيسر. الناب اللبني في مكانه.

ما النهج الصحيح؟

أ) الانتظار سنتين دون أخذ أي سجلات

ب) البدء فورًا بالكشف الجراحي والجرّ

ج) ترك الناب اللبني دون متابعة

د) تقييم الموضع بالصورة البانورامية، والتخطيط لتصوير إضافي (ثلاثي الأبعاد) عند الحاجة

السؤال 7

حالة

في القوس السفلية ازدحام 7 mm. منحنى Spee السفلي نحو 3 mm.

ما أفضل تفسير لإجمالي الحاجة إلى المسافة في القوس السفلية؟

أ) 7 mm للضبط

ب) 4 mm لأن منحنى Spee يوفّر مسافة

ج) أكثر من 7 mm؛ تسوية منحنى Spee تحتاج أيضًا إلى مسافة

د) لا يُحسب منحنى Spee في تحليل المسافة

السؤال 8

حالة

في تحليل Bolton النسبة الأمامية مرتفعة: الأسنان الأمامية السفلية كبيرة مقارنة بالعلوية.

أي حل يُعدّ خيارًا مطروحًا؟

أ) عدم توافق Bolton لا أثر سريري له

ب) التقليم بين السني (IPR) في الأمامية السفلية أو تكبير القواطع الجانبية العلوية ترميميًا

ج) قلع الضواحك العلوية إلزامي

د) يلزم توسيع سريع للفك العلوي

السؤال 9

حالة

العمر 14 سنة. انحراف إلى اليسار عند فتح الفم، وطقطقة في المفصل الفكي الصدغي الأيمن. لا يوجد ألم.

ماذا يُفعل قبل العلاج؟

أ) تدوين الموجودة في السجل الأولي، وإبلاغ المريض والأسرة، وطلب تقييم متقدم عند الحاجة

ب) عدم تدوين شيء لعدم وجود ألم

ج) رفض العلاج قطعيًا

د) تركيب جهاز وظيفي فورًا

السؤال 10

حالة

العمر 8 سنوات. ازدحام نحو 2 mm في القواطع الدائمة السفلية. الناب اللبني والأرحاء اللبنية في مكانها.

ما التفسير الصحيح؟

أ) يلزم حتمًا قلع الضواحك

ب) التوسيع السريع للفك العلوي إلزامي

ج) يجب البدء فورًا بالعلاج الثابت

د) شائع في الإسنان المختلط؛ يُتابع بتحليل المسافة ومسافة Leeway

المجموعة 1 · الإجابات والشرح

السؤال	الإجابة	الشرح
1	أ	**الصنف الثاني النوع 1.** زيادة البروز الأفقي وميل القواطع العلوية دهليزيًا يدلان على النوع 1. ويُقيَّم المنشأ الهيكلي بالقياسات السيفالومترية على حدة.
2	د	**الصنف الثاني النوع 2.** ميل القواطع المركزية حنكيًا، وميل الجانبية دهليزيًا، والعضة العميقة هي النمط النموذجي للنوع 2.
3	ج	**فحص الإطباق في العلاقة المركزية والتمييز بين الانزلاق الوظيفي واللاتناظر الحقيقي.** فرق الصنف في جانب واحد وانحراف الخط المتوسط يستلزمان أولًا فحص CR-CO؛ ولا تُختار الميكانيكا إلا بعد تحديد السبب.
4	ب	**انزلاق وظيفي بسبب ضيق الفك العلوي.** تصحّح الخطوط المتوسطة في العلاقة المركزية هو العلامة الأساسية للانزلاق الوظيفي.
5	أ	**زيادة عمودية في الفك العلوي أو بزوغ مفرط سني سنخي علوي.** إذا كان طول الشفة وطول التاج طبيعيين، تتقدم الأسباب العمودية الفكية والسنية السنخية في تفسير الابتسامة اللثوية.
6	د	**تقييم الموضع بالصورة البانورامية، والتخطيط لتصوير إضافي (ثلاثي الأبعاد) عند الحاجة.** عدم الجسّ في جانب واحد علامة تحذيرية للناب المنطمر؛ ويُقيَّم أولًا الموضع وجذور الأسنان المجاورة.
7	ج	**أكثر من 7 mm؛ فتسوية منحنى Spee تحتاج أيضًا إلى مسافة.** تسوية منحنى Spee العميق تتطلب مسافة إضافية على محيط القوس.
8	ب	**التقليم بين السني (IPR) في الأمامية السفلية أو تكبير القواطع الجانبية العلوية ترميميًا.** عدم توافق أحجام الأسنان يؤثر في البروز الأفقي ونقاط التماس عند الإنهاء؛ ويمكن موازنته بالتقليم بين السني أو بالتعديل الترميمي.
9	أ	**تدوين الموجودة في السجل الأولي، وإبلاغ المريض والأسرة، وطلب تقييم متقدم عند الحاجة.** يجب تسجيل موجودات المفصل الفكي الصدغي قبل بدء العلاج؛ ويُبلَّغ المريض ويُجرى تقييم متقدم عند الحاجة.
10	د	**شائع في الإسنان المختلط؛ يُتابع بتحليل المسافة ومسافة Leeway.** الازدحام الخفيف في القواطع السفلية شائع في الإسنان المختلط المبكر؛ ويُتخذ القرار بالمتابعة وتحليل المسافة.

عدد الإجابات الصحيحة: ___ / 10 التاريخ: تاريخ الإعادة:

المجموعة 2 · الأسئلة 11–20

القياسات السيفالومترية

للقراءة: الوحدة 02 · الخريطة البصرية 3، 40، 41، 42 · دفتر تمارين القياسات السيفالومترية

السؤال 11

حالة

SNA 82°, SNB 76°, ANB 6°.

ما التفسير الأدق؟

أ) صنف ثانٍ هيكلي يغلب عليه بروز الفك العلوي

ب) صنف أول هيكلي

ج) صنف ثالث هيكلي

د) صنف ثانٍ هيكلي يغلب عليه تراجع الفك السفلي

السؤال 12

حالة

SNA 86°, SNB 80°, ANB 6°.

ما التفسير الأدق؟

أ) صنف ثانٍ هيكلي يغلب عليه تراجع الفك السفلي

ب) صنف ثالث هيكلي

ج) صنف ثانٍ هيكلي يغلب عليه بروز الفك العلوي

د) علاقة سهمية طبيعية

السؤال 13

حالة

ANB 2°، وWits +5 mm. يبدو مستوى SN مائلًا بوضوح.

كيف يُفسَّر ذلك؟

أ) المريض صنف أول هيكلي حتمًا لأن ANB طبيعي

ب) قد يكون ANB مضلِّلًا؛ يُقيَّم مع Wits والمظهر الجانبي والقياسات الأخرى

ج) لا أهمية سريرية لقيمة Wits

د) ميل SN لا يؤثر في ANB

السؤال 14

حالة

FMA 34°, SN-GoMe 40°.

ما النمط العمودي؟

أ) مفرط التباعد (hyperdivergent)

ب) ناقص التباعد (hypodivergent)

ج) طبيعي التباعد (normodivergent)

د) لا يمكن التقييم بهذه القيم

السؤال 15

حالة

18° FMA. التغطية العمودية عميقة.

أي عبارة صحيحة في هذا النمط العمودي؟

أ) بزوغ الأرحاء ممنوع قطعيًا

ب) خطر العضة المفتوحة مرتفع

ج) الغرز الخلفي له الأولوية في الضبط العمودي

د) البزوغ الخلفي يُحتمل بشكل أفضل، لكن الميل إلى العضة العميقة أكبر

السؤال 16

حالة

102° IMPA. يُخطَّط لمطاط الصنف الثاني لمدة طويلة بهدف التمويه في الصنف الثاني.

ما الخطر الأهم؟

أ) ميل القواطع السفلية لسانيًا

ب) غرز الأرحاء العلوية

ج) ازدياد ميل القواطع السفلية الدهليزي أكثر؛ مع خطر لثوي وخطر على الثبات

د) ازدياد التغطية العمودية تلقائيًا

السؤال 17

حالة

115° U1-SN. البروز الأفقي 8 mm، و3° ANB.

ما التفسير الأدق للبروز الأفقي؟

أ) البروز الأفقي هيكلي بالكامل

ب) جزء كبير من البروز الأفقي ناتج عن ميل القواطع العلوية دهليزيًا

ج) القواطع العلوية مائلة حنكيًا

د) لا علاقة لميل القواطع بالبروز الأفقي

السؤال 18

حالة

مريض صنف ثالث. 112° U1-SN, 80° IMPA, −3° ANB.

علامَ تدل ميول القواطع؟

أ) تعويض سني سنخي طبيعي: القواطع العلوية مائلة دهليزيًا والسفلية مائلة لسانيًا

ب) اكتمل إلغاء التعويض

ج) القاطعتان كلتاهما بميل طبيعي

د) القواطع العلوية مائلة حنكيًا والسفلية مائلة دهليزيًا

السؤال 19

حالة

ترسم المستوى الفكي السفلي في التتبع السيفالومتري.

من أي نقطتين يمر المستوى الفكي السفلي في زاوية SN-GoMe؟

أ) Porion وOrbitale

ب) Sella وNasion

ج) ANS وPNS

د) Gonion وMenton

السؤال 20

حالة

ترسم مستوى Frankfort الأفقي لقياس FMA.

بأي نقطتين يُعرَّف مستوى Frankfort؟

أ) Nasion وSella

ب) ANS وPNS

ج) Porion وOrbitale

د) Gonion وMenton

المجموعة 2 · الإجابات والشرح

السؤال	الإجابة	الشرح
11	د	**صنف ثانٍ هيكلي يغلب عليه تراجع الفك السفلي.** SNA طبيعي وSNB منخفض: الفرق مصدره الفك السفلي.
12	ج	**صنف ثانٍ هيكلي يغلب عليه بروز الفك العلوي.** SNB طبيعي وSNA مرتفع: الفرق مصدره الفك العلوي.
13	ب	**قد يكون ANB مضلِّلًا؛ يُقيَّم مع Wits والمظهر الجانبي والقياسات الأخرى.** يتأثر ANB بميل مستوى SN وبموضع Nasion؛ وعند التعارض تكون القياسات الإضافية هي الحاسمة.
14	أ	**مفرط التباعد.** كلتا الزاويتين أعلى بوضوح من المعايير الكلاسيكية (FMA نحو 25°، وSN-GoMe نحو 32°).
15	د	**البزوغ الخلفي يُحتمل بشكل أفضل، لكن الميل إلى العضة العميقة أكبر.** النمط ناقص التباعد يتحمل البزوغ الخلفي؛ مع مراعاة الميل إلى العضة العميقة والانتكاس.
16	ج	**ازدياد ميل القواطع السفلية الدهليزي أكثر؛ مع خطر لثوي وخطر على الثبات.** مطاط الصنف الثاني يميل القواطع السفلية إلى الأمام؛ وهذا عامل مقيِّد في القواطع المائلة دهليزيًا أصلًا.
17	ب	**جزء كبير من البروز الأفقي ناتج عن ميل القواطع العلوية دهليزيًا.** U1-SN أعلى من الطبيعي بوضوح، وANB في الحد الطبيعي: المكوّن السني هو الغالب.
18	أ	**تعويض سني سنخي طبيعي: القواطع العلوية مائلة دهليزيًا والسفلية مائلة لسانيًا.** في الصنف الثالث تميل القواطع بطريقة تخفي عدم التوافق الهيكلي؛ وفي الخطة الجراحية يُلغى هذا التعويض.
19	د	**Gonion** وSN-GoMe **Menton.** هي الزاوية بين مستوى SN ومستوى Go-Me.
20	ج	**Porion** وOrbitale**.** يمر مستوى Frankfort الأفقي بنقطتي Porion وOrbitale.

عدد الإجابات الصحيحة: ___ / 10 التاريخ: تاريخ الإعادة:

المجموعة 3 · الأسئلة 21–30

التخطيط والتوقيت

للقراءة: الوحدة 03 · الخريطة البصرية 19، 43–52 · الأداة 4 · المخطّط السريري ذو المراحل الأربع

السؤال 21

حالة

العمر 13 سنة. صنف ثانٍ النوع 1، عضة عميقة، ازدحام خفيف. ستكتب قائمة المشكلات.

ما النهج الصحيح؟

أ) اختيار الجهاز أولًا ثم كتابة المشكلات بناءً عليه

ب) كتابة شكوى المريض فقط

ج) كتابة المشكلات منفصلة تحت عناوين: سهمي، عمودي، عرضي، مسافة، ثم ترتيب أولوياتها

د) سرد القيم السيفالومترية فقط

السؤال 22

حالة

العمر 8 سنوات. قاطع علوي واحد في عضة معكوسة أمامية. يمكن الوصول إلى وضع حد لحد في العلاقة المركزية. بدأ انحسار اللثة في القاطع السفلي.

ما القرار الأنسب؟

أ) الانتظار حتى اكتمال الإسنان الدائم

ب) النظر في التصحيح المبكر

ج) التخطيط لجراحة تقويم الفكين

د) إعطاء صفيحة ليلية فقط

السؤال 23

حالة

العمر 7 سنوات. ميل خفيف للصنف الثاني، البروز الأفقي 4 mm، لا سوابق رضّية. الطفل ليس مستعدًا للعلاج بعد.

ما النهج الأنسب؟

أ) المتابعة وإعادة التقييم في مرحلة النمو

ب) البدء فورًا بالعلاج الثابت

ج) التخطيط لقلع الضواحك العلوية

د) طلب استشارة جراحية

السؤال 24

حالة

العمر 18 سنة، ذكر. صنف ثالث. ANB −6°، وWits −10 mm. شكوى واضحة من المظهر الجانبي.

ما الخطوة الأولى الأنسب؟

أ) البدء فورًا بالتمويه بمطاط الصنف الثالث

ب) اقتراح قناع الوجه

ج) وضعه تحت المتابعة دون عرض أي خيار

د) التأكد من اكتمال النمو واقتراح استشارة جراحة تقويم الفكين

السؤال 25

حالة

العمر 16 سنة، أنثى. صنف ثانٍ، ANB 5°، المظهر الجانبي مقبول. لا ازدحام في القوس السفلية، والنمو مكتمل إلى حد كبير.

أي خيار يمكن النظر فيه؟

أ) قلع أربعة ضواحك إلزامي

ب) قناع الوجه

ج) التمويه مع قلع الضواحك العلوية

د) التوسيع السريع للفك العلوي وحده

السؤال 26

حالة

العمر 14 سنة. صنف ثانٍ بنصف وحدة. الالتزام بالمطاط والجهاز المتحرك ضعيف.

أي الخيارات أقل اعتمادًا على الالتزام؟

أ) جهاز وظيفي متحرك

ب) جهاز وظيفي ثابت أو ميكانيكا مدعومة بالغرسات المصغّرة

ج) مطاط الصنف الثاني

د) صفيحة متحركة تُلبس ليلًا

السؤال 27

حالة

العمر 40 سنة. يوجد فقد عظمي لثوي والتهاب نشط.

متى يبدأ العلاج التقويمي؟

أ) بعد إتمام علاج اللثة واستقرار المرض

ب) فورًا؛ فالتقويم يخفف الالتهاب

ج) لا يمكن البدء أبدًا

د) فقط بعد وضع الزرعات

السؤال 28

حالة

القاطع الجانبي العلوي الأيمن مفقود خلقيًا. شكل الناب ولونه مناسبان، ومستوى اللثة مختلف.

كيف يُتخذ قرار إغلاق المسافة أو فتحها؟

أ) تُفتح المسافة دائمًا للزرعة

ب) تُغلق المسافة دائمًا

ج) القرار لطبيب التعويضات وحده

د) بقرار الفريق بعد تقييم شكل الناب واللون ومستوى اللثة والإطباق والمظهر الجانبي معًا

السؤال 29

حالة

تخطط للتسلسل الميكانيكي.

ما الترتيب الصحيح؟

أ) الإنهاء ← التسوية ← مرحلة العمل ← التثبيت

ب) مرحلة العمل ← التسوية ← التثبيت ← الإنهاء

ج) التسوية والمحاذاة ← مرحلة العمل ← الإنهاء ← التثبيت

د) التثبيت ← التسوية ← الإنهاء ← مرحلة العمل

السؤال 30

حالة

تُعدّ VTO لحالة بالغ.

ما الهدف الأساسي من VTO؟

أ) ضمان النتيجة النهائية

ب) رؤية الأثر المحتمل للتغييرات المخطط لها على المظهر الجانبي والإطباق مسبقًا

ج) أن تحل محل نموذج الموافقة المعتمد في عيادتك

د) جعل القياسات السيفالومترية غير ضرورية

المجموعة 3 · الإجابات والشرح

السؤال	الإجابة	الشرح
21	ج	**كتابة المشكلات منفصلة تحت عناوين: سهمي، عمودي، عرضي، مسافة، ثم ترتيب أولوياتها.** تُكتب قائمة المشكلات حسب الأبعاد؛ وتُختار الميكانيكا في النهاية.
22	ب	**النظر في التصحيح المبكر.** الانزلاق الوظيفي والإجهاد اللثوي هما المبرران الكلاسيكيان للعلاج المبكر.
23	أ	**المتابعة وإعادة التقييم في مرحلة النمو.** إن لم يوجد مبرر للعلاج المبكر، فالعلاج بمرحلة واحدة في الوقت المناسب أكفأ غالبًا.
24	د	**التأكد من اكتمال النمو واقتراح استشارة جراحة تقويم الفكين.** عدم التوافق الهيكلي الكبير مع شكوى المظهر الجانبي يستلزمان مناقشة الخيار الجراحي.
25	ج	**التمويه مع قلع الضواحك العلوية.** إذا كانت القوس السفلية منتظمة، يمكن التخطيط للتمويه بالقلع العلوي فقط مع إنهاء الأرحاء في الصنف الثاني.
26	ب	**جهاز وظيفي ثابت أو ميكانيكا مدعومة بالغرسات المصغّرة.** عند ضعف الالتزام تتقدم الخيارات التي لا تعتمد على تركيب المريض للجهاز ونزعه.
27	أ	**بعد إتمام علاج اللثة واستقرار المرض.** في المرض اللثوي النشط قد يُسرّع تحريك الأسنان فقد العظم.
28	د	**بقرار الفريق بعد تقييم شكل الناب واللون ومستوى اللثة والإطباق والمظهر الجانبي معًا.** لا توجد إجابة واحدة صحيحة في فقد القاطع الجانبي؛ تُوزن المعايير التجميلية والإطباقية واللثوية معًا.
29	ج	**التسوية والمحاذاة ← مرحلة العمل ← الإنهاء ← التثبيت.** لا يُنتقل إلى أسلاك العمل الصلبة وإغلاق المسافات قبل اكتمال التسوية.
30	ب	**رؤية الأثر المحتمل للتغييرات المخطط لها على المظهر الجانبي والإطباق مسبقًا.** VTO أداة تخطيط؛ وليست ضمانًا للنتيجة.

عدد الإجابات الصحيحة: ___ / 10 التاريخ: تاريخ الإعادة:

المجموعة 4 · الأسئلة 31–40

إدارة المسافة

للقراءة: الوحدة 04 · الخريطة البصرية 14، 16، 18، 53–61 · الأداة 2 · خريطة القرار: القلع أم الحفاظ؟

السؤال 31

حالة

العمر 17 سنة. صنف أول. ازدحام 9 mm في الأسفل، بروز ثنائي الفكين، والشفتان بارزتان.

ما الخيار الأقوى؟

أ) التقليم بين السني (IPR) فقط

ب) خطة مع القلع

ج) خطة دون قلع مع تقديم القواطع أكثر

د) المتابعة فقط

السؤال 32

حالة

العمر 26 سنة. ازدحام 2.5 mm في القواطع السفلية. شكل التيجان مثلثي، ونظافة الفم جيدة.

أي خيار مناسب؟

أ) التقليم بين السني (IPR)

ب) قلع أربعة ضواحك

ج) التوسيع السريع للفك العلوي

د) جراحة تقويم الفكين

السؤال 33

حالة

خطر تسوس مرتفع، ونظافة فم غير كافية، وتيجان صغيرة. ازدحام خفيف في القواطع السفلية.

ما القرار الصحيح بشأن التقليم بين السني؟

أ) إجراء أكبر قدر ممكن من التقليم

ب) ترك أسطح التقليم دون صقل

ج) عدم أخذ عوامل الخطر في الحسبان

د) تجنّب التقليم بين السني أو حصره في أضيق نطاق

السؤال 34

حالة

العمر 10 سنوات. عضة معكوسة خلفية ثنائية الجانب. الفك العلوي ضيق والحنك عميق.

ما الخيار الأنسب؟

أ) المطاطات المتصالبة فقط

ب) تضييق القوس السفلية

ج) التوسيع السريع للفك العلوي (RME)

د) الانتظار حتى انتهاء النمو

السؤال 35

حالة

العمر 22 سنة. ضيق عرضي هيكلي. عظم دهليزي رقيق، ونمط لثوي رقيق.

أي نهج أصحّ؟

أ) التوسيع بإمالة الأسنان دهليزيًا فقط

ب) تقييم التوسيع المدعوم بالغرسات المصغّرة أو بالجراحة مع رأي أخصائي اللثة

ج) تطبيق RME دون أي تقييم

د) تجاهل الضيق العرضي

السؤال 36

حالة

العمر 9 سنوات. فُقدت الرحى اللبنية الثانية السفلية اليسرى مبكرًا. لا يزال أمام بزوغ الضاحك التالي وقت. لا يوجد فقد في المسافة بعد.

ما الخيار الأنسب؟

أ) حافظ المسافة

ب) عدم فعل أي شيء

ج) قلع الضاحك فورًا

د) مطاط الصنف الثالث

السؤال 37

حالة

العمر 11 سنة. الأرحاء اللبنية الثانية السفلية لا تزال في مكانها. ازدحام 3 mm في القواطع السفلية.

أي خيار قد يسهم في كسب المسافة؟

أ) قلع الأرحاء اللبنية مبكرًا

ب) قلع القواطع السفلية

ج) التوسيع السريع للفك العلوي

د) قوس لساني للحفاظ على مسافة Leeway

السؤال 38

حالة

يُجرى إرجاع الأرحاء العلوية نحو الوحشي.

ما الأثر الجانبي المتوقع في وحدة الارتكاز؟

أ) ميل القواطع حنكيًا

ب) إرجاع الأرحاء السفلية نحو الوحشي

ج) تحرك الضواحك والقواطع نحو الأنسي وميل القواطع دهليزيًا

د) ازدياد التغطية العمودية تلقائيًا

السؤال 39

حالة

العمر 16 سنة. صنف ثانٍ النوع 1. القوس السفلية منتظمة. ستُقلع الضواحك الأولى العلوية فقط.

ما علاقة الأرحاء والأنياب المستهدفة عند الإنهاء؟

أ) الأرحاء صنف أول، والأنياب صنف أول

ب) الأرحاء صنف ثانٍ، والأنياب صنف أول

ج) الأرحاء صنف ثالث، والأنياب صنف ثانٍ

د) الأرحاء صنف أول، والأنياب صنف ثانٍ

السؤال 40

حالة

يلزم القلع في القوس السفلية، لكن لا يُرغب في إرجاع القواطع السفلية كثيرًا.

أي قلع يمكن تفضيله؟

أ) الضاحك الثاني السفلي

ب) الضاحك الأول السفلي

ج) الناب السفلي

د) القاطع المركزي السفلي

المجموعة 4 · الإجابات والشرح

السؤال	الإجابة	الشرح
31	ب	**خطة مع القلع.** الازدحام الشديد والبروز موجودتان قويتان لصالح القلع.
32	أ	**التقليم بين السني (IPR).** الازدحام الخفيف وشكل التيجان المثلثي ظروف مناسبة للتقليم بين السني.
33	د	**تجنّب التقليم بين السني أو حصره في أضيق نطاق.** خطر التسوس وصغر حجم التيجان موجودات ضد التقليم بين السني.
34	ج	**التوسيع السريع للفك العلوي (RME).** في مرحلة النمو يمكن معالجة الضيق العرضي الهيكلي بـRME.
35	ب	**تقييم التوسيع المدعوم بالغرسات المصغّرة أو بالجراحة مع رأي أخصائي اللثة.** عند البالغ ومع النمط الرقيق، يزيد التوسيع السني وحده خطر فقد اللثة والعظم.
36	أ	**حافظ المسافة.** عند الفقد المبكر للرحى اللبنية قد يؤدي تحرك الرحى الدائمة نحو الأنسي إلى فقد المسافة.
37	د	**قوس لساني للحفاظ على مسافة Leeway.** إذا حُفظت مسافة Leeway التي تتكشف عند تبديل الأرحاء اللبنية، فقد تسهم في حل الازدحام.
38	ج	**تحرك الضواحك والقواطع نحو الأنسي وميل القواطع دهليزيًا.** القوة المساوية والمعاكسة لقوة الإرجاع الوحشي تدفع أسنان الارتكاز إلى الأمام.
39	ب	**الأرحاء صنف ثانٍ، والأنياب صنف أول.** في القلع العلوي فقط تبقى الأرحاء العلوية في مكانها؛ وتُوصل الأنياب إلى الصنف الأول.
40	أ	**الضاحك الثاني السفلي.** قلع الضاحك الثاني يتيح إرجاعًا أقل للقواطع السفلية وتحريكًا للأرحاء نحو الأنسي.

عدد الإجابات الصحيحة: ___ / 10 التاريخ: تاريخ الإعادة:

المجموعة 5 · الأسئلة 41–50

الارتكاز والغرسات المصغّرة

للقراءة: الوحدة 04 · الخريطة البصرية 11، 62–66

السؤال 41

حالة

بروز ثنائي الفكين. قلع أربعة ضواحك، والمطلوب إرجاع القواطع قدر الإمكان.

ما خيار الارتكاز الأكثر موثوقية؟

أ) ارتكاز مباشر بالغرسة المصغّرة

ب) سلسلة مطاطية دون دعم ارتكاز

ج) مطاط الصنف الثاني فقط

د) صفيحة ليلية فقط

السؤال 42

حالة

أثناء إغلاق المسافات تقدمت الأرحاء العلوية 3 mm نحو الأنسي، وانخفض البروز الأفقي أقل من المتوقع.

ما المشكلة؟

أ) امتصاص الجذور

ب) انزلاق وظيفي

ج) عدم توافق Bolton

د) فقد الارتكاز

السؤال 43

حالة

تفكر في استخدام TPA.

ما التأثير الأساسي لـTPA؟

أ) يوفّر وحده ارتكازًا سهميًا مطلقًا

ب) يغرز القواطع السفلية

ج) يحافظ على العلاقة العرضية بين الأرحاء ويضبط دوران الأرحاء

د) يوسّع الفك العلوي هيكليًا

السؤال 44

حالة

يُخطَّط لجهاز Nance لارتكاز إضافي في القوس العلوية.

من أين يستمد جهاز Nance دعمه؟

أ) من القواطع السفلية

ب) من زر أكريلي يرتكز على مخاطية الحنك الأمامي

ج) من الغرسات المصغّرة

د) من خارج الفم

السؤال 45

حالة

تخطط لوضع غرسة مصغّرة.

ما الذي يُفحص أولًا قبل الوضع؟

أ) المسافة بين الجذور وكمية العظم؛ واللثة الملتصقة إن أمكن

ب) المنطقة التي يفضّلها المريض فقط

ج) لون الحاصرة فقط

د) لا يلزم أي تقييم شعاعي

السؤال 46

حالة

الغرسة المصغّرة متحركة بعد بضعة أسابيع من وضعها.

ما الأسباب الأكثر احتمالًا؟

أ) عمر المريض هو السبب الوحيد دائمًا

ب) عدم ملاءمة لون المطاط

ج) تغيير نوع الحاصرة

د) التماس مع الجذر، أو عظم غير كافٍ، أو التهاب حولها

السؤال 47

حالة

رُبطت الغرسة المصغّرة بضاحك، وتُطبَّق القوة من الضاحك.

ما نوع هذا الارتكاز؟

أ) ارتكاز مباشر

ب) ارتكاز خارج فموي

ج) ارتكاز غير مباشر

د) ارتكاز متبادل

السؤال 48

حالة

بالغ. الرحى الأولى العلوية متطاولة بسبب فقد السن المقابل. تلزم مسافة عمودية للتعويض.

أي ميكانيكا يمكن النظر فيها؟

أ) مزيد من بزوغ الرحى

ب) غرز الرحى بدعم الغرسة المصغّرة

ج) مطاط الصنف الثاني

د) التوسيع السريع للفك العلوي

السؤال 49

حالة

بالغ. نمط مفرط التباعد، وعضة مفتوحة أمامية 3 mm.

أي خيار يستهدف المشكلة العمودية؟

أ) تقييم الغرز الخلفي بالغرسات المصغّرة

ب) مطاط الصنف الثاني لمدة طويلة

ج) البزوغ الخلفي

د) توسيع سني غير مضبوط

السؤال 50

حالة

يوجد تضخم لثوي وحساسية حول الغرسة المصغّرة.

ما النهج الأول؟

أ) زيادة القوة

ب) تجاهل الموجودة

ج) إضافة غرسة ثانية بجانب الغرسة المصغّرة

د) ضبط النظافة والالتهاب؛ وإن لم يتحسن، نزع الغرسة المصغّرة وتقييم موضع آخر

المجموعة 5 · الإجابات والشرح

السؤال	الإجابة	الشرح
41	أ	**ارتكاز مباشر بالغرسة المصغّرة.** في الحالات التي تحتاج إلى أقصى ارتكاز، الغرسة المصغّرة هي الخيار الموثوق الأقل احتياجًا إلى التزام المريض.
42	د	**فقد الارتكاز.** تحرك الأرحاء نحو الأنسي وعدم انخفاض البروز الأفقي بما يكفي هما الموجودتان النموذجيتان لفقد الارتكاز.
43	ج	**يحافظ على العلاقة العرضية بين الأرحاء ويضبط دوران الأرحاء.** إسهام TPA في الارتكاز السهمي محدود؛ وأثره الأساسي هو الضبط العرضي وضبط الدوران.
44	ب	**من زر أكريلي يرتكز على مخاطية الحنك الأمامي.** يستمد جهاز Nance دعمه من المخاطية الحنكية عبر الزر الأكريلي؛ وتُراقب النظافة تحت الزر.
45	أ	**المسافة بين الجذور وكمية العظم؛ واللثة الملتصقة إن أمكن.** التماس مع الجذر وعدم كفاية العظم من أكثر أسباب الفشل شيوعًا.
46	د	**التماس مع الجذر، أو عظم غير كافٍ، أو التهاب حولها.** في الغرسة المصغّرة المتحركة يُقيَّم الموضع والعظم والنظافة؛ وتُعاد إلى موضع آخر عند الحاجة.
47	ج	**ارتكاز غير مباشر.** في الارتكاز غير المباشر تثبّت الغرسة المصغّرة سنًا، وتُطبَّق القوة من ذلك السن.
48	ب	**غرز الرحى بدعم الغرسة المصغّرة.** تتيح الغرسة المصغّرة غرز رحى واحدة دون التأثير في الأسنان المجاورة.
49	أ	**تقييم الغرز الخلفي بالغرسات المصغّرة.** قد يقلل الغرز الخلفي العضة المفتوحة بالسماح بدوران الفك السفلي إلى الأمام والأعلى.
50	د	**ضبط النظافة والالتهاب؛ وإن لم يتحسن، نزع الغرسة المصغّرة وتقييم موضع آخر.** الالتهاب يرفع خطر الفشل؛ ويُقيَّم أولًا مستوى النظافة والحِمل.

عدد الإجابات الصحيحة: ___ / 10 التاريخ: تاريخ الإعادة:

المجموعة 6 · الأسئلة 51–60

الصنف الثاني

للقراءة: الوحدة 05 · الخريطة البصرية 12، 15، 67–72، 77 · الأداة 3 · الصنف الثاني أم الثالث: المميِّز البصري

السؤال 51

حالة

العمر 12 سنة. الأرحاء صنف ثانٍ. ANB 2°. القواطع العلوية مائلة دهليزيًا.

ما طبيعة هذا الصنف الثاني بالدرجة الأولى؟

أ) هيكلي، تراجع الفك السفلي

ب) هيكلي، بروز الفك العلوي

ج) انزلاق وظيفي

د) سني

السؤال 52

حالة

العمر 11 سنة، ذكر. ANB 7°, FMA 24°, SNB 74°. قريب من طفرة النمو، ومتعاون.

أي خيار يتقدم؟

أ) جراحة تقويم الفكين

ب) قناع الوجه

ج) جهاز وظيفي

د) قلع الضواحك السفلية فقط

السؤال 53

حالة

العمر 10 سنوات. البروز الأفقي 10 mm. توجد سوابق رضّية واحتباس الشفة السفلية خلف القواطع.

ما القرار الأنسب؟

أ) الانتظار حتى اكتمال الإسنان الدائم

ب) النظر في تقليل البروز الأفقي مبكرًا

ج) تقديم القواطع السفلية فقط

د) المتابعة فقط

السؤال 54

حالة

علاج Twin Block جارٍ.

ما الأثر الجانبي السني السنخي الأكثر نموذجية؟

أ) ميل القواطع السفلية دهليزيًا

ب) ميل القواطع السفلية لسانيًا

ج) ميل القواطع العلوية دهليزيًا

د) حدوث عضة معكوسة خلفية

السؤال 55

حالة

يُستخدم مطاط الصنف الثاني.

أيّها أثر جانبي نموذجي؟

أ) ميل القواطع السفلية لسانيًا

ب) غرز الأرحاء العلوية

ج) زيادة البروز الأفقي

د) بزوغ الأرحاء السفلية وميل القواطع السفلية دهليزيًا

السؤال 56

حالة

FMA 35°. صنف ثانٍ، مع ميل خفيف إلى العضة المفتوحة. يُنظر في مطاط الصنف الثاني لمدة طويلة.

ما التفسير الصحيح؟

أ) هو الخيار الأكثر أمانًا لدى المريض مفرط التباعد

ب) لا أثر له على البعد العمودي

ج) يجب الحذر؛ فبزوغ الأرحاء قد يدير الفك السفلي نحو الخلف فيسوء المظهر الجانبي

د) يغلق العضة المفتوحة دائمًا

السؤال 57

حالة

صنف ثانٍ النوع 2، والتغطية العمودية عميقة.

ماذا يُفعل أولًا في العلاج؟

أ) البدء فورًا بمطاط الصنف الثاني

ب) تصحيح ميل القواطع المركزية العلوية وفتح العضة العميقة

ج) قلع القواطع السفلية

د) تركيب جهاز التثبيت أولًا

السؤال 58

حالة

مريض صنف ثانٍ لا يزال في طور النمو، مع قلق بشأن الالتزام.

أي خيار يقلل الاعتماد على الالتزام؟

أ) جهاز وظيفي ثابت

ب) جهاز وظيفي متحرك

ج) مطاط الصنف الثاني

د) صفيحة ليلية

السؤال 59

حالة

العمر 20 سنة. ANB 9°، البروز الأفقي 11 mm، تراجع واضح في الفك السفلي، وشكوى من المظهر الجانبي.

ما النهج الأنسب؟

أ) مطاط الصنف الثاني فقط

ب) جهاز وظيفي

ج) التقليم بين السني (IPR) فقط

د) استشارة جراحة تقويم الفكين

السؤال 60

حالة

في تمويه الصنف الثاني تُرجَع القواطع العلوية.

إلامَ يُنتبه أكثر؟

أ) إلى تقويم القواطع عموديًا قدر الإمكان

ب) إلى زيادة القوة قدر الإمكان

ج) إلى ضبط العزم (torque)؛ وتجنّب الميل الحنكي المفرط للقواطع

د) إلى تعميق التغطية العمودية

المجموعة 6 · الإجابات والشرح

السؤال	الإجابة	الشرح
51	د	**سني.** عندما يكون ANB طبيعيًا، تُفسَّر علاقة الصنف الثاني بوضع الأسنان.
52	ج	**جهاز وظيفي.** تراجع الفك السفلي والنمط العمودي الطبيعي ومرحلة النمو المناسبة ظروف ملائمة للجهاز الوظيفي.
53	ب	**النظر في تقليل البروز الأفقي مبكرًا.** زيادة البروز الأفقي والسوابق الرضّية مبرران قويان للتدخل المبكر.
54	أ	**ميل القواطع السفلية دهليزيًا.** في الأجهزة الوظيفية تميل القواطع السفلية إلى الأمام؛ ويجب مراقبتها.
55	د	**بزوغ الأرحاء السفلية وميل القواطع السفلية دهليزيًا.** يسحب مطاط الصنف الثاني القوس السفلية إلى الأمام وقد يسبب بزوغ الأرحاء السفلية.
56	ج	**يجب الحذر؛ فبزوغ الأرحاء قد يدير الفك السفلي نحو الخلف فيسوء المظهر الجانبي.** النمط مفرط التباعد حساس للميكانيكا المسببة للبزوغ.
57	ب	**تصحيح ميل القواطع المركزية العلوية وفتح العضة العميقة.** لا يمكن قراءة العلاقة السهمية بدقة قبل تصحيح القواطع المائلة حنكيًا والعضة العميقة.
58	أ	**جهاز وظيفي ثابت.** الأجهزة الوظيفية الثابتة لا تعتمد على تركيب المريض للجهاز ونزعه.
59	د	**استشارة جراحة تقويم الفكين.** في عدم التوافق الهيكلي الكبير بعد اكتمال النمو تُستنفد حدود التمويه.
60	ج	**إلى ضبط العزم (torque)؛ وتجنّب الميل الحنكي المفرط للقواطع.** فقد العزم يؤثر سلبًا في الجمال وفي التغطية العمودية معًا.

عدد الإجابات الصحيحة: ___ / 10 التاريخ: تاريخ الإعادة:

المجموعة 7 · الأسئلة 61–70

الصنف الثالث

للقراءة: الوحدة 05 · الخريطة البصرية 13، 73–76

السؤال 61

حالة

العمر 7 سنوات. عضة معكوسة أمامية. في العلاقة المركزية القواطع حدًّا لحد. المظهر الجانبي في وضع الراحة مستقيم.

ما التشخيص الأرجح؟

أ) صنف ثالث هيكلي

ب) الصنف الثاني النوع 2

ج) الصنف الثالث الكاذب

د) العضة المقصّية (scissor bite)

السؤال 62

حالة

العمر 8 سنوات. ANB −3°, SNB 80°, SNA 77°. بروز أفقي سلبي.

أي خيار يمكن النظر فيه؟

أ) جراحة تقويم الفكين فورًا

ب) سحب الفك العلوي إلى الأمام بقناع الوجه في مرحلة مبكرة

ج) مطاط الصنف الثاني

د) قلع الضواحك السفلية

السؤال 63

حالة

العمر 9 سنوات. الأب لديه صنف ثالث. ANB −2°.

ماذا يجب أن يُشرح للأسرة؟

أ) الفائدة المحتملة للعلاج المبكر، وإمكانية الانتكاس مع النمو، واحتمال الحاجة إلى علاج إضافي لاحقًا

ب) أن العلاج المبكر سيحل المشكلة حلًا قاطعًا ودائمًا

ج) أن أي علاج لن يفيد

د) أنها مشكلة جمالية فقط

السؤال 64

حالة

بالغ. ANB −2°، المظهر الجانبي مقبول، والمريض لا يرغب في الجراحة.

كيف تُحرَّك القواطع في التمويه؟

أ) تُمال القواطع العلوية للخلف، والسفلية للأمام

ب) تُقوَّم القاطعتان كلتاهما عموديًا

ج) لا تُحرَّك القواطع

د) تُمال القواطع العلوية للأمام، والسفلية للخلف

السؤال 65

حالة

تحضير تقويمي قبل جراحة تقويم الفكين للصنف الثالث.

ما هدف مرحلة التحضير؟

أ) زيادة التعويض

ب) إغلاق البروز الأفقي السلبي بالكامل

ج) إلغاء التعويض: إيصال القواطع إلى الميل الصحيح بالنسبة إلى العظم القاعدي

د) التصحيح إلى حد الاستغناء عن الجراحة

السؤال 66

حالة

يُستخدم مطاط الصنف الثالث.

ما الأثر الجانبي النموذجي؟

أ) ميل القواطع السفلية دهليزيًا

ب) ميل القواطع العلوية دهليزيًا، وميل القواطع السفلية لسانيًا، وبزوغ الأرحاء العلوية

ج) غرز الأرحاء العلوية

د) زيادة البروز الأفقي

السؤال 67

حالة

يُخطَّط لعلاج بقناع الوجه.

ما المرحلة الأنسب؟

أ) الإسنان المختلط المبكر، بينما نمو الفك العلوي مستمر

ب) بعد اكتمال النمو

ج) في البلوغ فقط

د) بعد بزوغ الأرحاء الدائمة الثانية بسنوات

السؤال 68

حالة

العمر 26 سنة. قاطع جانبي علوي واحد في عضة معكوسة. ينقص القوس نحو 2 mm من المسافة.

كيف يكون ترتيب التصحيح؟

أ) دفع القاطع أولًا بالقوة نحو الشفوي

ب) جراحة تقويم الفكين

ج) عدم فعل أي شيء

د) فتح المسافة أولًا، ثم تحريك القاطع نحو الشفوي

السؤال 69

حالة

عضة معكوسة أمامية.

أي موجودة توحي بصنف ثالث هيكلي حقيقي؟

أ) وصول القواطع إلى وضع حد لحد في العلاقة المركزية

ب) أن يكون قاطع واحد فقط في عضة معكوسة

ج) استمرار البروز الأفقي السلبي في العلاقة المركزية أيضًا، مع مظهر جانبي مقعّر وسوابق عائلية

د) مظهر جانبي مستقيم وانزلاق وظيفي

السؤال 70

حالة

العمر 15 سنة، ذكر. صنف ثالث هيكلي، ويُنظر في الجراحة. النمو مستمر.

كيف يُحدَّد توقيت الجراحة؟

أ) تُجرى فورًا أثناء استمرار النمو

ب) يُنتظر اكتمال النمو؛ ويُتحقق منه بسجلات متتابعة

ج) تُخطَّط في اليوم نفسه بغض النظر عن العمر

د) التوقيت لا يؤثر في النتيجة

المجموعة 7 · الإجابات والشرح

السؤال	الإجابة	الشرح
61	ج	**الصنف الثالث الكاذب.** التماس حدًّا لحد في العلاقة المركزية والمظهر الجانبي المستقيم يوحيان بانزلاق وظيفي أمامي.
62	ب	**سحب الفك العلوي إلى الأمام بقناع الوجه في مرحلة مبكرة.** في تراجع الفك العلوي يُقيَّم السحب الأمامي المبكر خلال مرحلة النمو.
63	أ	**الفائدة المحتملة للعلاج المبكر، وإمكانية الانتكاس مع النمو، واحتمال الحاجة إلى علاج إضافي لاحقًا.** في الصنف الثالث العائلي قد يغيّر النمو النتيجة؛ لذا تُضبط التوقعات بدقة منذ البداية.
64	د	**تُمال القواطع العلوية للأمام، والسفلية للخلف.** يخفي التمويه عدم التوافق الهيكلي بالتعويض السني السنخي؛ مع مراعاة حدوده.
65	ج	**إلغاء التعويض: إيصال القواطع إلى الميل الصحيح بالنسبة إلى العظم القاعدي.** قد يزداد البروز الأفقي السلبي مؤقتًا أثناء إلغاء التعويض؛ ويُبلَّغ المريض بذلك مسبقًا.
66	ب	**ميل القواطع العلوية دهليزيًا، وميل القواطع السفلية لسانيًا، وبزوغ الأرحاء العلوية.** يسحب مطاط الصنف الثالث القوس العلوية إلى الأمام والسفلية إلى الخلف.
67	أ	**الإسنان المختلط المبكر، بينما نمو الفك العلوي مستمر.** الأثر الهيكلي للسحب الأمامي أكبر في المرحلة المبكرة.
68	د	**فتح المسافة أولًا، ثم تحريك القاطع نحو الشفوي.** لا يمكن إدخال السن إلى القوس دون مسافة؛ وتُضاف رافعات عضة مؤقتة عند الحاجة.
69	ج	**استمرار البروز الأفقي السلبي في العلاقة المركزية أيضًا، مع مظهر جانبي مقعّر وسوابق عائلية.** في الصنف الثالث الكاذب يمكن التماس حدًّا لحد في العلاقة المركزية؛ أما في الصنف الثالث الحقيقي فلا.
70	ب	**يُنتظر اكتمال النمو؛ ويُتحقق منه بسجلات متتابعة.** الجراحة أثناء استمرار النمو قد تُفسد نموَّ الفك السفلي اللاحق نتيجتَها.

عدد الإجابات الصحيحة: ___ / 10 التاريخ: تاريخ الإعادة:

المجموعة 8 · الأسئلة 71–80

المشكلات العمودية والعرضية

للقراءة: الوحدة 06 · الخريطة البصرية 4–6، 79–92

السؤال 71

حالة

العمر 9 سنوات. عادة مصّ الإصبع. عضة مفتوحة أمامية 3 mm. FMA 26°.

ما النوع الأرجح والهدف الأول؟

أ) عضة مفتوحة هيكلية؛ جراحة تقويم الفكين

ب) عضة مفتوحة سنية مرتبطة بالعادة؛ ترك العادة أولًا

ج) انزلاق وظيفي؛ RME

د) عضة عميقة؛ غرز

السؤال 72

حالة

العمر 14 سنة. FMA 36°، زيادة في ارتفاع الوجه الأمامي السفلي، وعضة مفتوحة أمامية 4 mm.

بماذا توحي هذه الصورة؟

أ) عضة مفتوحة هيكلية؛ الأولوية للضبط العمودي

ب) عضة مفتوحة سنية فقط

ج) نمط ناقص التباعد

د) ميل إلى العضة العميقة

السؤال 73

حالة

العمر 11 سنة. اللسان بين القواطع أثناء البلع. اضطراب في نطق صوت «س». عضة مفتوحة 2 mm.

ما النهج الأنسب؟

أ) الإغلاق بالمطاطات العمودية فقط

ب) الانتظار دون فعل أي شيء

ج) قلع الضواحك

د) خطة متعددة التخصصات مع أخصائي النطق، وشبكة لسان عند الحاجة

السؤال 74

حالة

التغطية العمودية 6 mm. ظهور القواطع العلوية في الراحة زائد. اللثة ظاهرة عند الابتسام.

كيف تُفتح العضة العميقة؟

أ) بزوغ القواطع العلوية

ب) البزوغ الخلفي فقط

ج) غرز القواطع العلوية بالدرجة الأولى

د) مطاط الصنف الثاني

السؤال 75

حالة

التغطية العمودية 6 mm. ظهور القواطع العلوية في الراحة قليل. FMA 20°.

أي خيار أنسب؟

أ) غرز القواطع العلوية

ب) البزوغ الخلفي و/أو غرز القواطع السفلية

ج) الغرز الخلفي

د) عدم استخدام أي ميكانيكا عمودية

السؤال 76

حالة

العمر 24 سنة. الرحى الأولى العلوية اليسرى وحدها في عضة معكوسة. عرض القوس العلوية كافٍ.

ما النهج الأنسب؟

أ) تصحيح سني موضعي

ب) التوسيع السريع للفك العلوي

ج) توسيع بمساعدة جراحية

د) قناع الوجه

السؤال 77

حالة

يُستخدم مطاط متصالب لعضة معكوسة في رحى واحدة.

ما الأثر الجانبي النموذجي؟

أ) غرز الأسنان

ب) ميل القواطع دهليزيًا

ج) تصحّح الخط المتوسط

د) بزوغ الأسنان

السؤال 78

حالة

تُطبق الأسنان الخلفية العلوية دهليزيًا بالكامل بالنسبة إلى السفلية.

ما اسم هذه العضة؟

أ) عضة معكوسة خلفية

ب) عضة مفتوحة

ج) العضة المقصّية (scissor bite)

د) انزلاق وظيفي

السؤال 79

حالة

العمر 18 سنة. عضة معكوسة خلفية ثنائية الجانب. نمط لثوي رقيق، والضواحك مائلة دهليزيًا أصلًا.

أي خيار أكثر أمانًا؟

أ) إمالة الأسنان دهليزيًا أكثر

ب) تقييم خيارات التوسيع الهيكلي مع رأي أخصائي اللثة

ج) الاستمرار طويلًا بالمطاطات المتصالبة

د) عدم إجراء أي تقييم

السؤال 80

حالة

ظهور لثوي زائد عند الابتسام. التيجان السريرية قصيرة. ظهور القواطع طبيعي.

أي سبب يجب التفكير فيه؟

أ) البزوغ المنفعل؛ تقييم لثوي

ب) الزيادة العمودية في الفك العلوي تشخيص مؤكد

ج) بروز الفك السفلي

د) انزلاق وظيفي

المجموعة 8 · الإجابات والشرح

السؤال	الإجابة	الشرح
71	ب	**عضة مفتوحة سنية مرتبطة بالعادة؛ ترك العادة أولًا.** العضة المفتوحة المصاحبة لعادة في نمط عمودي طبيعي سنية في الغالب.
72	أ	**عضة مفتوحة هيكلية؛ الأولوية للضبط العمودي.** ارتفاع FMA وزيادة ارتفاع الوجه الأمامي السفلي يدلان على المكوّن الهيكلي.
73	د	**خطة متعددة التخصصات مع أخصائي النطق، وشبكة لسان عند الحاجة.** العضة المفتوحة التي تُغلق دون معالجة الوظيفة العضلية تميل إلى الانتكاس.
74	ج	**غرز القواطع العلوية بالدرجة الأولى.** زيادة ظهور القواطع تجعل غرز القواطع العلوية هو الخيار المفضل جماليًا.
75	ب	**البزوغ الخلفي و/أو غرز القواطع السفلية.** مع قلة ظهور القواطع يضر الغرز العلوي بالابتسامة؛ والنمط منخفض الزاوية يتحمل البزوغ الخلفي.
76	أ	**تصحيح سني موضعي.** العضة المعكوسة في سن واحد مع عرض قوس كافٍ تدل على مشكلة سنية.
77	د	**بزوغ الأسنان.** المكوّن العمودي للمطاطات المتصالبة يسبب بزوغ الأسنان؛ ويُراقب خاصة لدى المريض مفرط التباعد.
78	ج	**العضة المقصّية (scissor bite).** في العضة المقصّية يُفقد التماس تمامًا في الاتجاه الدهليزي اللساني.
79	ب	**تقييم خيارات التوسيع الهيكلي مع رأي أخصائي اللثة.** في الأسنان المائلة تعويضيًا يزيد التوسيع السني الإضافي الخطر اللثوي.
80	أ	**البزوغ المنفعل؛ تقييم لثوي.** قِصر التيجان السريرية مع ظهور طبيعي للقواطع يوحي بالبزوغ المنفعل.

عدد الإجابات الصحيحة: ___ / 10 التاريخ: تاريخ الإعادة:

المجموعة 9 · الأسئلة 81–90

الميكانيكا المساعدة

للقراءة: الوحدة 07 · الخريطة البصرية 93–104

السؤال 81

حالة

أثناء إغلاق المسافات تتعمق التغطية العمودية في القواطع ويُفقد العزم. السلك صغير والقوة عالية.

ما الذي يجب تغييره؟

أ) تقليل القوة، والانتقال إلى سلك فولاذي مستطيل يملأ الشق بشكل أفضل، وضبط العزم

ب) زيادة القوة أكثر

ج) الانتقال إلى سلك دائري أرفع

د) تجاهل تعمّق التغطية العمودية

السؤال 82

حالة

سيبدأ إغلاق المسافات بميكانيكا الانزلاق.

ما الشرط قبل البدء؟

أ) بقاء سلك NiTi المرن في مكانه

ب) عدم اكتمال تركيب الحاصرات بعد

ج) تركيب جهاز التثبيت

د) اكتمال التسوية ووجود سلك عمل مستطيل مناسب

السؤال 83

حالة

يُنظر في ميكانيكا العُرى (loop).

ما ميزتها الأساسية؟

أ) أنها لا تحتاج إلى أي تنشيط

ب) أنها تسهّل النظافة

ج) أنها خالية من الاحتكاك؛ ويمكن ضبط القوة والعزم بهندسة الثني

د) أنها تعتمد على التزام المريض

السؤال 84

حالة

صُحّح قاطع جانبي ذو دوران واضح.

ما السبب الأساسي لانتكاس الدوران؟

أ) تغيّر لون الحاصرة

ب) تأخر إعادة تنظيم الألياف اللثوية فوق العرف السنخي

ج) زيادة البروز الأفقي

د) عدم استخدام الغرسة المصغّرة

السؤال 85

حالة

ناب علوي منطمر حنكيًا. المسافة متوفرة، والموضع محدد.

ما المهم قبل الجرّ؟

أ) وحدة ارتكاز صلبة، وتخطيط اتجاه القوة بعيدًا عن الجذور المجاورة

ب) أن تكون القوة أعلى ما يمكن

ج) ترك أسنان الارتكاز على سلك مرن

د) عدم إجراء تصوير إضافي

السؤال 86

حالة

في جرّ الناب المنطمر لا توجد حركة رغم مرور أشهر، وأسنان الارتكاز تنغرز.

بماذا يجب التفكير؟

أ) مضاعفة القوة

ب) تجاهل انغراز أسنان الارتكاز

ج) الانتقال إلى التثبيت

د) اشتباه التحام السن بالعظم؛ تقييم مفصّل (الدليل 4 · الرضوض والتحام الأسنان)

السؤال 87

حالة

تُعدَّل الرحى الثانية السفلية إلى الوضع القائم.

ما الأثر الجانبي النموذجي؟

أ) غرز الرحى

ب) ميل القواطع لسانيًا

ج) بزوغ الرحى وتماس إطباقي مبكر

د) عضة معكوسة خلفية

السؤال 88

حالة

تلزم في القوس العلوية توسعة سنية سنخية خفيفة إلى متوسطة وتصحيح دوران الأرحاء.

أي جهاز مناسب؟

أ) قناع الوجه

ب) Quad helix

ج) Twin Block

د) مثبِّت لساني ثابت

السؤال 89

حالة

أُجري إرجاع الأرحاء العلوية وحشيًا بجهاز Pendulum.

ما الأثر الجانبي المتوقع؟

أ) تقدّم الضواحك والقواطع نحو الأنسي؛ وميل وحشي (tipping) في الأرحاء

ب) ميل القواطع لسانيًا

ج) ميل الأرحاء نحو الأنسي

د) توسّع القوس السفلية

السؤال 90

حالة

كسر في القاطع المركزي العلوي يمتد تحت اللثة. طول الجذر كافٍ. يلزم حد مناسب للترميم.

ما الذي يمكن أن يقدمه التقويم؟

أ) غرز تقويمي

ب) التوسيع السريع للفك العلوي

ج) مطاط الصنف الثالث

د) بزوغ تقويمي (البزوغ القسري)

المجموعة 9 · الإجابات والشرح

السؤال	الإجابة	الشرح
81	أ	**تقليل القوة، والانتقال إلى سلك فولاذي مستطيل يملأ الشق بشكل أفضل، وضبط العزم.** السلك غير الصلب والقوة الزائدة يؤديان إلى ميل القواطع للخلف دون ضبط.
82	د	**اكتمال التسوية ووجود سلك عمل مستطيل مناسب.** إغلاق المسافات قبل انتهاء التسوية يُفقد ضبط العزم والدوران.
83	ج	**أنها خالية من الاحتكاك؛ ويمكن ضبط القوة والعزم بهندسة الثني.** العُرى تلغي مشكلة الاحتكاك لكنها تتطلب ثنيًا وتنشيطًا دقيقين.
84	ب	**تأخر إعادة تنظيم الألياف اللثوية فوق العرف السنخي.** تبقى الألياف فوق العرف السنخي مشدودة مدة طويلة؛ فيُقيَّم التثبيت وقطع الألياف (fiberotomy) عند الحاجة.
85	أ	**وحدة ارتكاز صلبة، وتخطيط اتجاه القوة بعيدًا عن الجذور المجاورة.** إذا كان اتجاه القوة خاطئًا يزداد خطر امتصاص الجذور المجاورة.
86	د	**اشتباه التحام السن بالعظم؛ تقييم مفصّل (الدليل 4 · الرضوض والتحام الأسنان).** عدم الحركة مع ظهور آثار جانبية في أسنان الارتكاز يوحيان بالتحام السن بالعظم.
87	ج	**بزوغ الرحى وتماس إطباقي مبكر.** في التعديل إلى الوضع القائم يرفع الدوران حول قمة الجذر الأنسي الرحى إلى الأعلى.
88	ب	**Quad helix.** يُستخدم Quad helix للتوسعة السنية الخفيفة إلى المتوسطة وتصحيح دوران الأرحاء.
89	أ	**تقدّم الضواحك والقواطع نحو الأنسي؛ وميل وحشي (tipping) في الأرحاء.** تتقدم وحدة الارتكاز إلى الأمام؛ وقد تميل الأرحاء نحو الوحشي دون ضبط.
90	د	**بزوغ تقويمي (البزوغ القسري).** يرفع البزوغ حد الكسر فوق اللثة فيسهّل الترميم.

عدد الإجابات الصحيحة: ___ / 10 التاريخ: تاريخ الإعادة:

المجموعة 10 · الأسئلة 91–100

الإنهاء والتثبيت والرضوض والتحام السن بالعظم

للقراءة: الوحدة 08 · الخريطة البصرية 20، 105–114 · الدليل 2 · دليل التثبيت التقويمي · الدليل 4 · الرضوض والتحام الأسنان

السؤال 91

حالة

عند الإنهاء، مستويات الحواف الحافية للأسنان المتجاورة مختلفة.

ماذا يُفعل؟

أ) نزع الحاصرات فورًا

ب) زيادة القوة

ج) محاولة تصحيح الفرق بالتثبيت

د) إعادة تموضع الحاصرات المعنية

السؤال 92

حالة

تفحص توازي الجذور في مرحلة الإنهاء.

ما النهج الصحيح؟

أ) النظر إلى مظهر التيجان فقط

ب) عدم استخدام أي صورة شعاعية

ج) التقييم على الصورة البانورامية، مع مراعاة التشوّه وتفسيرها مع الموجودات السريرية

د) اعتبار الصورة البانورامية قياسًا قاطعًا

السؤال 93

حالة

الإنهاء. الخط المتوسط السفلي منحرف 2 mm إلى اليمين. لا يوجد لاتناظر هيكلي ولا انزلاق وظيفي.

أي ميكانيكا مناسبة؟

أ) جراحة تقويم الفكين

ب) تصحيح سني بميكانيكا غير متناظرة أو مطاطات غير متناظرة

ج) التوسيع السريع للفك العلوي

د) عدم إجراء أي تصحيح

السؤال 94

حالة

علاقات القواطع جيدة، لكن التماسات الخلفية في منطقة الضواحك ضعيفة.

أي طريقة يمكن استخدامها؟

أ) استقرار الإطباق بسلك إنهاء مرن أو بمطاطات عمودية لفترة قصيرة

ب) زيادة القوة دون نزع الحاصرات

ج) التوسيع السريع للفك العلوي

د) الغرز الخلفي

السؤال 95

حالة

في البداية كان هناك فلج علوي (diastema) ودورانات في القواطع السفلية.

أي تثبيت يُوصى به؟

أ) لا حاجة إلى التثبيت

ب) صفيحة متحركة لمدة شهر فقط

ج) نصائح العناية الفموية فقط

د) مثبِّت لساني ثابت، مع صفيحة ليلية عند الحاجة

السؤال 96

حالة

مريض نظافته الفموية ضعيفة، ولا يرغب في المثبِّت اللساني الثابت، ومتعاون.

أي خيار يمكن النظر فيه؟

أ) عدم استخدام أي تثبيت

ب) جراحة تقويم الفكين

ج) مثبِّت متحرك (Hawley أو مثبِّت شفاف) مع متابعة لصيقة

د) تركيب المثبِّت اللساني الثابت رغم رغبة المريض

السؤال 97

حالة

بعد ثلاث سنوات من انتهاء العلاج عاد الازدحام في القواطع السفلية. تُرك استخدام المثبِّتات.

ما التفسير الأرجح؟

أ) أن العلاج لم يُفد إطلاقًا

ب) عدم الالتزام بالتثبيت والتغيرات الفسيولوجية المستمرة مع العمر

ج) عدم توافق Bolton فقط

د) مشكلة في المفصل الفكي الصدغي فقط

السؤال 98

حالة

في زيارة المتابعة يُلاحظ انفصال إحدى نقاط لصق المثبِّت اللساني الثابت. لم ينتبه المريض لذلك.

ماذا يُفعل؟

أ) إصلاح مبكر وفحص ما إذا كانت هناك حركة سنية في تلك المنطقة

ب) الانتظار حتى زيارة المتابعة السنوية التالية

ج) نزع المثبِّت كليًا دون اقتراح بديل

د) عدم تسجيل الموجودة

السؤال 99

حالة

العمر 10 سنوات. في السوابق رضّ على القاطع المركزي العلوي. يُخطَّط لعلاج تقويمي.

ماذا يُفعل في البداية؟

أ) عدم تسجيل السوابق الرضّية

ب) تطبيق أعلى قوة على السن المصاب

ج) البدء بالعلاج دون تقييم

د) تقييم سريري وشعاعي للسن المصاب وتسجيله؛ وخطة بقوى خفيفة

السؤال 100

حالة

رحى لبنية في حالة انخفاض إطباقي (infraocclusion)، والأسنان المجاورة مائلة فوقها. لا يوجد سن دائم تحتها.

ما التشخيص والنهج الأرجح؟

أ) بزوغ طبيعي؛ الانتظار فقط

ب) انزلاق وظيفي

ج) التحام السن بالعظم؛ قرار فريق في الوقت المناسب من حيث المسافة ومستوى العظم

د) مطاط الصنف الثاني

المجموعة 10 · الإجابات والشرح

السؤال	الإجابة	الشرح
91	د	**إعادة تموضع الحاصرات المعنية.** فرق الحواف الحافية يستلزم تصحيح موضع الحاصرة.
92	ج	**التقييم على الصورة البانورامية، مع مراعاة التشوّه وتفسيرها مع الموجودات السريرية.** الصورة البانورامية مرشدة، لكنها قد تتضمن تشوّهًا.
93	ب	**تصحيح سني بميكانيكا غير متناظرة أو مطاطات غير متناظرة.** انحراف الخط المتوسط ذو المنشأ السني يمكن تصحيحه بميكانيكا سنية.
94	أ	**استقرار الإطباق بسلك إنهاء مرن أو بمطاطات عمودية لفترة قصيرة.** الاستقرار الإطباقي (settling) يحسّن التماسات الخلفية.
95	د	**مثبِّت لساني ثابت، مع صفيحة ليلية عند الحاجة.** الفلج والدورانات موجودات عالية الخطر للانتكاس.
96	ج	**مثبِّت متحرك (Hawley) أو مثبِّت شفاف) مع متابعة لصيقة.** يُختار التثبيت مع مراعاة النظافة والالتزام وتفضيل المريض.
97	ب	**عدم الالتزام بالتثبيت والتغيرات الفسيولوجية المستمرة مع العمر.** تميل الأسنان إلى الحركة مدى الحياة؛ ولذلك يُخطَّط للتثبيت على المدى الطويل.
98	أ	**إصلاح مبكر وفحص ما إذا كانت هناك حركة سنية في تلك المنطقة.** إذا لم يُكتشف الانفصال فقد تحدث حركة سنية غير مرغوبة.
99	د	**تقييم سريري وشعاعي للسن المصاب وتسجيله؛ وخطة بقوى خفيفة.** تُقيَّم الأسنان المصابة برضّ قبل العلاج وتُسجَّل؛ والتفاصيل في الدليل 4 · الرضوض والتحام الأسنان.
100	ج	**التحام السن بالعظم؛ قرار فريق في الوقت المناسب من حيث المسافة ومستوى العظم.** في الرحى اللبنية الملتحمة بالعظم قد يؤدي التأخير إلى ميل الأسنان المجاورة وإلى فرق في مستوى العظم.

عدد الإجابات الصحيحة: ___ / 10 التاريخ: تاريخ الإعادة:

مادة تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري ولا عن قرار الطبيب ولا عن رأي الأخصائي.

الخطوة التالية

هل أنهيت الأسئلة المئة؟ اختر المجموعتين اللتين حصلت فيهما على أقل عدد من الإجابات الصحيحة، وارجع إلى الأسابيع المرتبطة بهما في «برنامج التدريب على الحالات لمدة 52 أسبوعًا».

إذا حصلت على أقل من 8 في مجموعة القياسات السيفالومترية فافتح **«دفتر تمارين القياسات السيفالومترية»**. ولمناقشة حالاتك مع زملائك استخدم **«قوالب عرض الحالة للزملاء»**.

ولتسريع القرارات بجانب كرسي العلاج احتفظ بالقرب منك بأداتين من دليل طبيب التقويم: **الأداة 2 · خريطة القرار: القلع أم الحفاظ؟** و**الأداة 3 · الصنف الثاني أم الثالث: المميِّز البصري**.